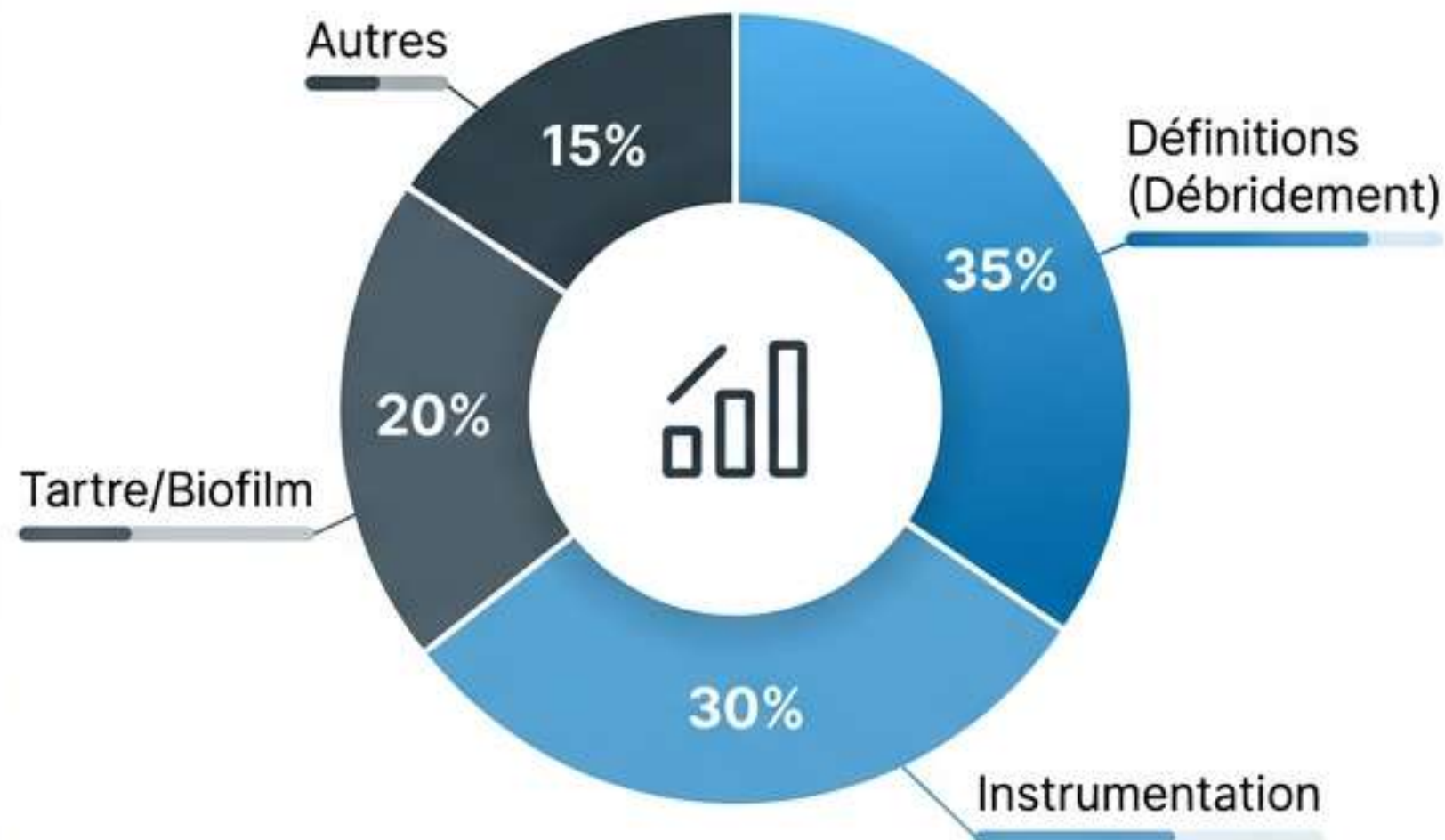


Analyse Stratégique des Examens

Intelligence Basée sur 23 Questions Précédentes

Fréquence des Thèmes



Piège Fréquent (Trap Alert)

Confusion entre Surfaçage (élimine le ciment) et Débridement (préserve le ciment).



Zones à Haut Rendement

- Différence Curette Universelle vs Gracey
- Caractéristiques du Tartre Sous-gingival
- Contre-indications Ultrasons

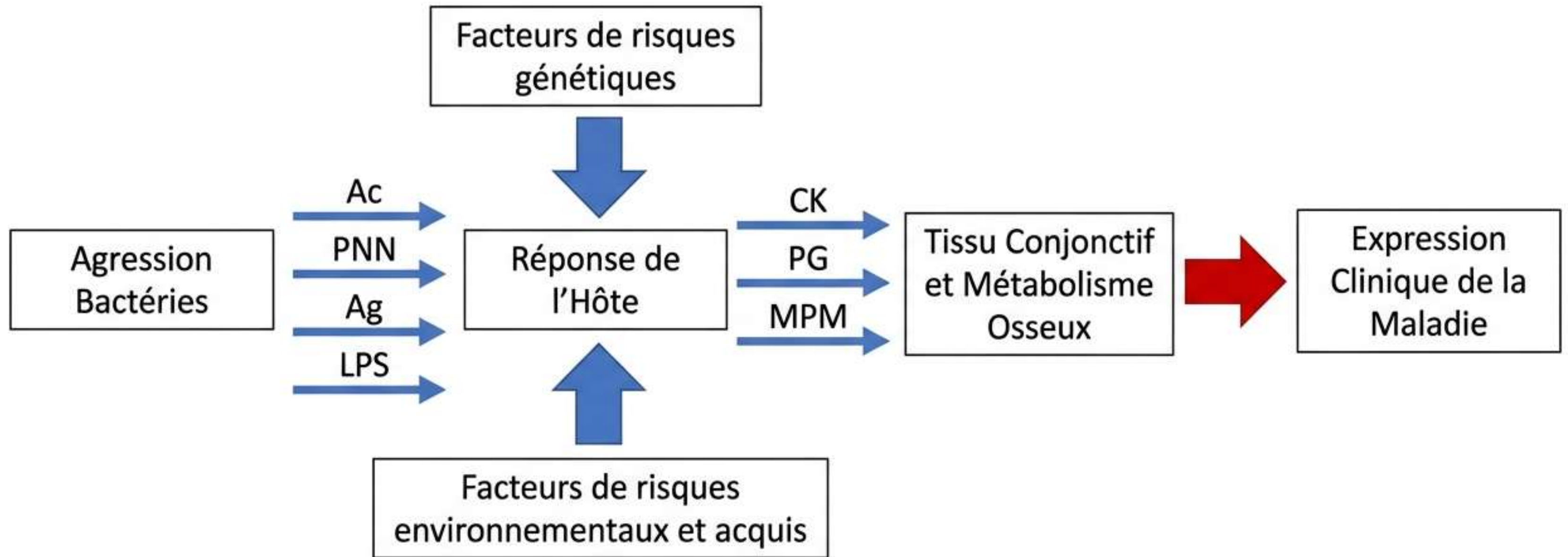


Statistiques Clés

- Questions Manuelles vs Ultrasons : 15% fréquence
- Questions Tartre : 20% fréquence

Focus Stratégique : Maîtriser les définitions exactes (Costerton) et les angles de travail (60-80°).

Étiologie et Biofilm (Rappels)



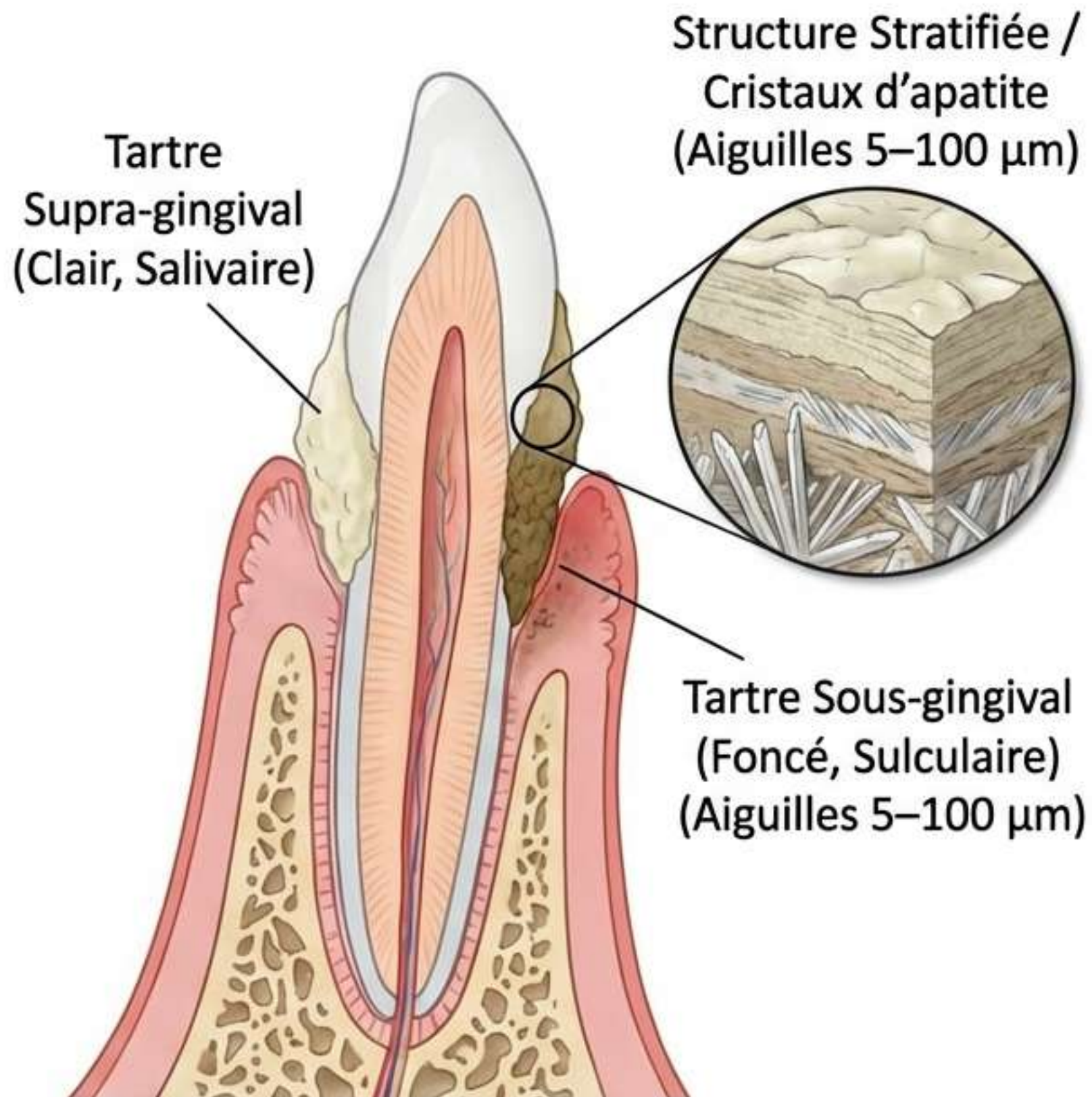
Définition Biofilm

Costerton 1994 : Association de bactéries (même ou plusieurs espèces) adhérant à une surface, matrice d'exopolymères, canaux aqueux.

Chaîne Causale (Section 2.1)

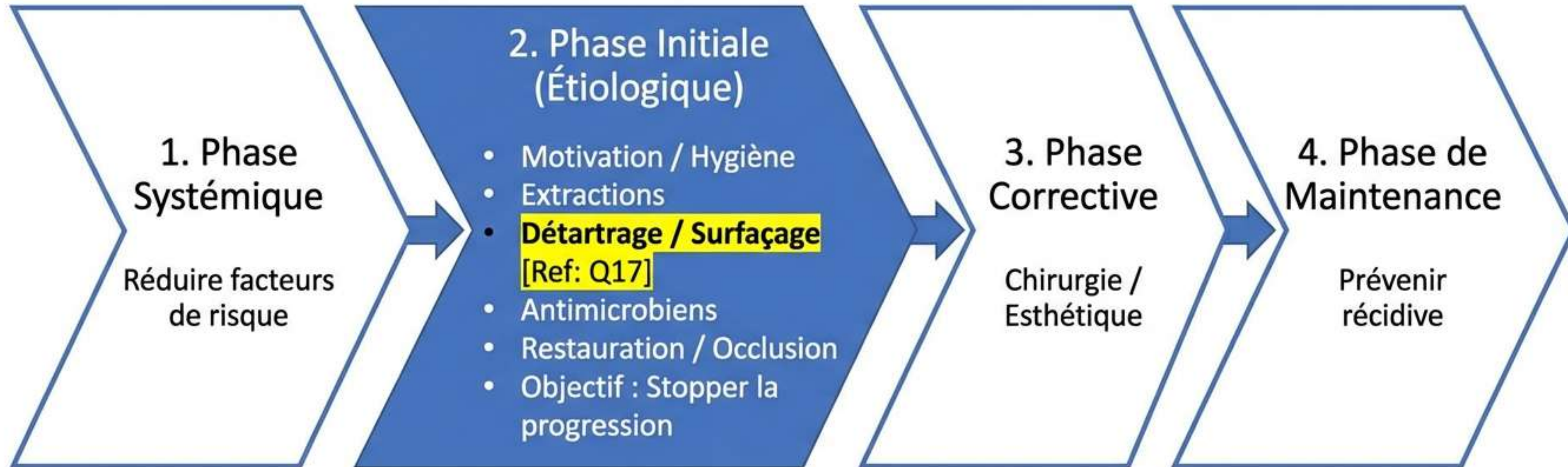
- Cause Directe : Microbienne (Biofilm)
- Facteurs Favorisants : Tartre, obturations débordantes
- Facteurs Modifiants : Facteurs généraux (pathogénie)

Le Tartre : Structure et Composition



Composition	Classification
Inorganique : 70-80% (Rapport Ca/P : 1.66 – 2)	Supra-gingival : Face linguale incisives inf, Face vestibulaire molaires sup.
Organique : ~20% (Protéines, hydrates de carbone)	Sous-gingival : Origine sulculaire.
Formes Cristallines Hydroxyapatite Whitlockite de magnésium (Cible : Sous-gingival) Phosphate octocalcique Brushite (Cible : Sus-gingival)	Sous-gingival : Couleur sombre et très adhérent. [Ref: Q7, Q9]

Plan de Traitement Parodontal (Lindhe)



Le Détartrage-Surfaçage est le 'Gold Standard' de la phase initiale.

Définitions : Le 'Gold Standard'

Détartrage

Élimination des dépôts de plaque, tartre et colorations (Supra & Sous-gingival).

Détartrage

Surfaçage Radic

Surfaçage Radiculaire

Élimination de la flore, du tartre résiduel, et du **cément/dentine contaminés**.

Débrid

Débridement Parodontal (Terme Actuel)

Traitement plus conservateur. Décontamination radiculaire + élimination des agents toxiques (Biofilm/Tartre) sur couronne et racine. **[Ref: Q1, Q5, Q23]**

Attention : N'inclut PAS l'élimination systématique du cément (lissage).
[Ref: Q6]

Concept : Surfaçage = Débridement Parodontal.

Objectifs et Contre-Indications

✓ Objectifs Thérapeutiques

- ✓ **Préparer les tissus à la chirurgie parodontale** [Ref: Q2]
- ✓ Stopper la progression de la maladie
- ✓ Réduire l'inflammation et le saignement
- ✓ Gain d'attache et réduction de la profondeur de poche
- ✓ Rendre la surface radiculaire biocompatible

⚠ Contre-Indications & Risques

- ⚠ 1. Risque Infectieux
 - ⚠ Nécessite Antibioprophylaxie
- ⚠ 2. Risque Hémorragique
 - ⚠ Nécessite Bilan Biologique
 - ⚠ **Limite de sécurité : INR < 4** [Predicted Value]

Limites du Traitement Non-Chirurgical

1. Compétence / Dextérité tactile (Approche en aveugle)

2. Profondeur de poche ≥ 6 mm

Note : Détartrage sous-gingival insuffisant → Chirurgie nécessaire.

3. Anatomie Complexe
- Concavités, Furcations, Dents distales

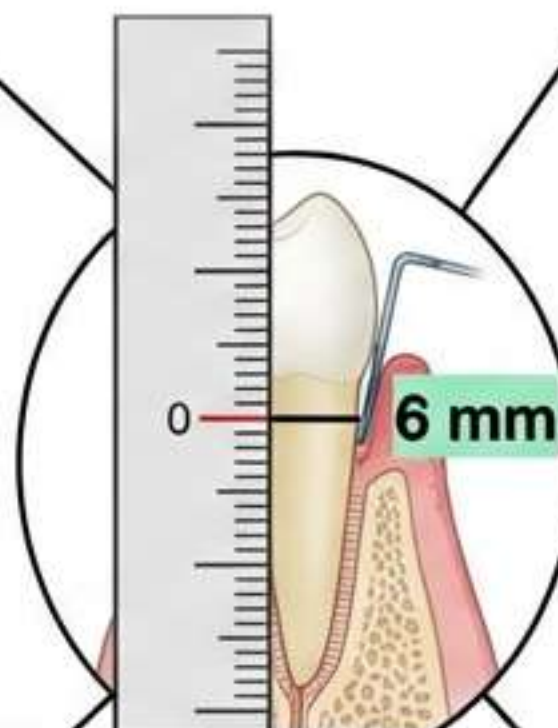
Profondeur de poche ≥ 6 mm

5. Temps

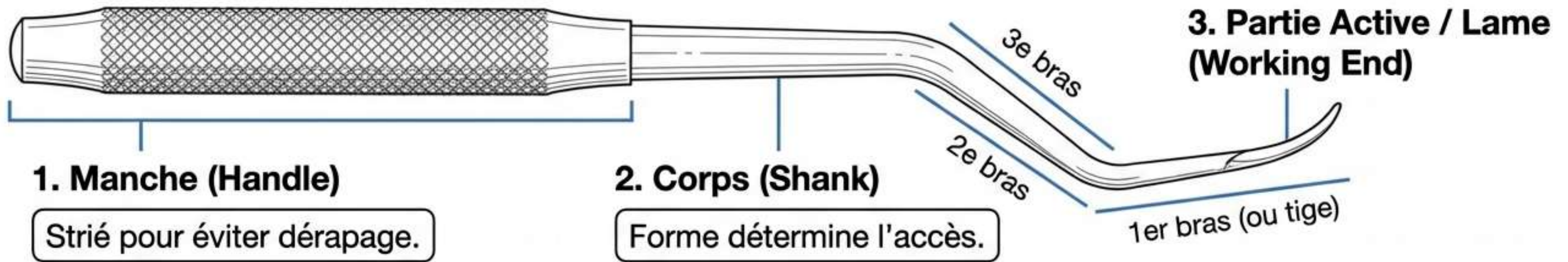
- Réduction de poche plus lente que la chirurgie.

4. Tissus mous

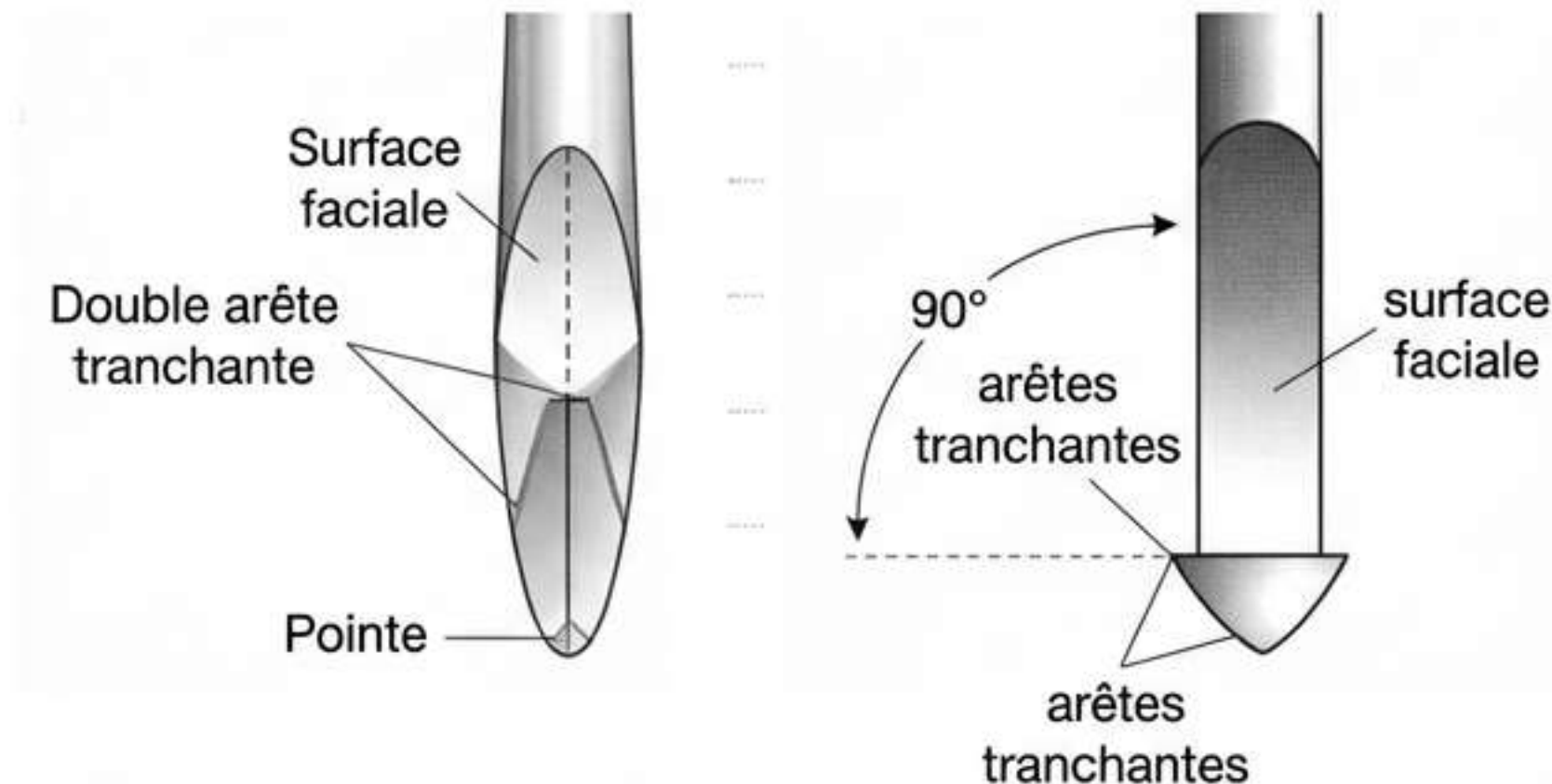
- Le surfaçage n'élimine pas systématiquement le tissu de granulation. [Ref: Q10]



Instrumentation Manuelle : Anatomie et Détartreurs



Détartreur Faucille (Sickle)



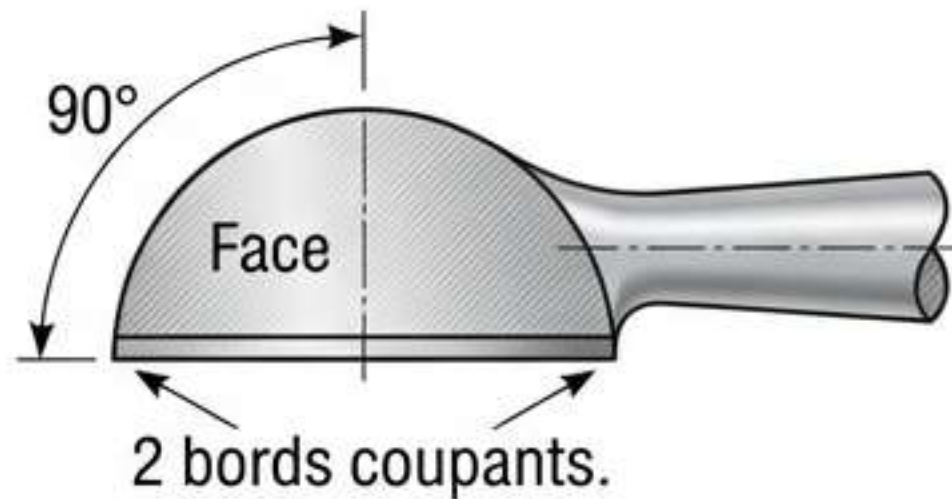
- **Section :** Triangulaire (2 bords coupants, pointe aiguë).
- **Indication :** Tartre Supra, Juxta, et légèrement Infra-gingival.
- **Contre-indication :** Poches profondes (Risque de traumatisme tissulaire).

⚠ Faux ami : L'instrumentation manuelle n'est pas uniquement supra-gingivale (La curette va en sous-gingival). [Ref : Q13]

La Curette : L'Instrument de Choix

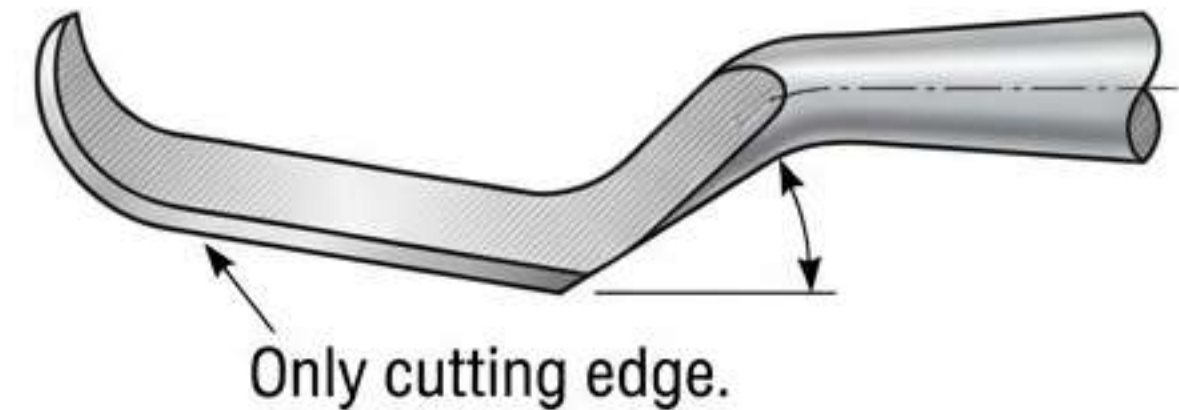
Comparaison Universelle vs Gracey

Curette Universelle



- **2 bords coupants.**
- Face à 90° du corps.
- Utilisation : Toutes surfaces.

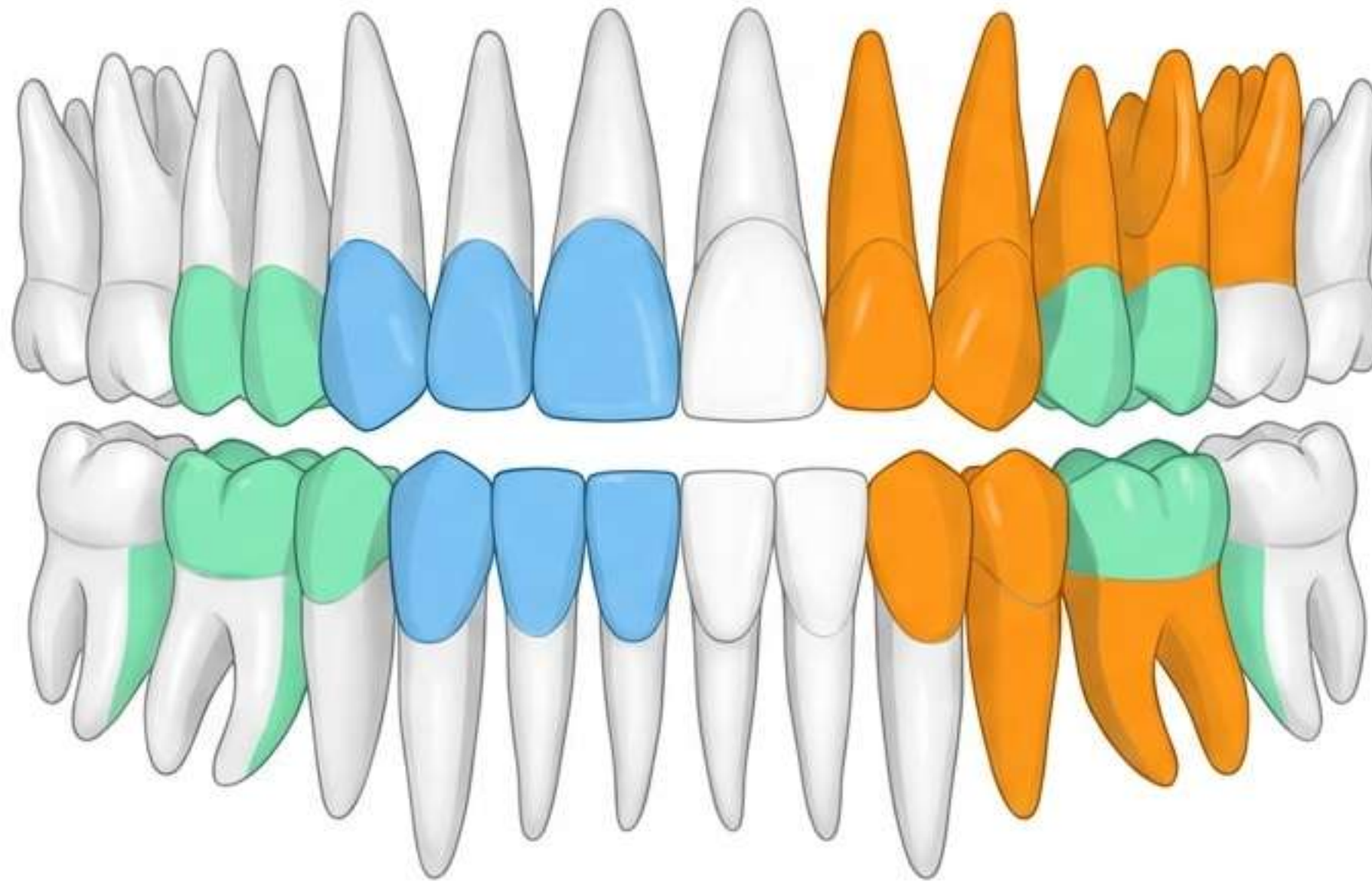
Curette Gracey



- **Area Specific** (Zone spécifique).
- **1 seul** bord coupant (Bord inférieur).
- Face inclinée (Offset).

**La Curette est l'instrument de choix pour le surfaçage radiculaire /
débridement sous-gingival. [Ref: Q4, Q21]**

Séquence des Curettes de Gracey



1. Gracey 5/6

Incisives & Canines (Toutes faces)

2. Gracey 7/8

Prémolaires & Molaires (Faces Vestibulaires, Linguales, Palatines)

3. Gracey 11/12

Prémolaires & Molaires : **Face Mésiale & Furcation.** [Predicted]

4. Gracey 13/14

Prémolaires & Molaires : **Face Distale & Furcation.** [Predicted]

Side Note : Variantes : After Five, Mini Five (pour poches profondes/étroites).

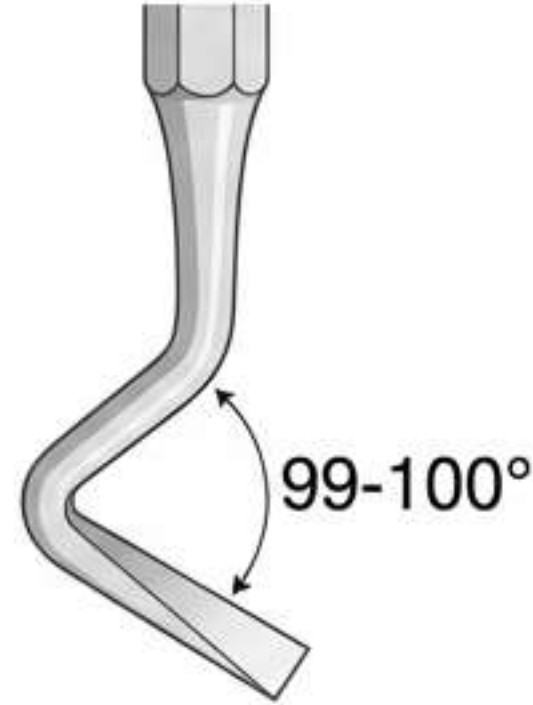
Instruments Spéciaux (Dégrossissage)

Ciseaux (Chisels)



- Usage : Tartre supra-gingival volumineux.
- Zone : Rétro-incisive inférieure.

Houes (Hoes)



- Usage : Volumineux tartre Sus/Sous-gingival.
- Mouvement : Traction.
- Zone : Faces V/L dents postérieures, Distale dernières molaires.

Limes (Files)



- Usage : **Fracturer** et dégrossir le tartre tenace.
- Role : Prépare le terrain pour la curette.

Instrumentation Mécanisée : Sonique vs Ultrasonique

Sonique

Source : Air comprimé

Fréquence : < 6,000 Hz



Mouvement : Elliptique

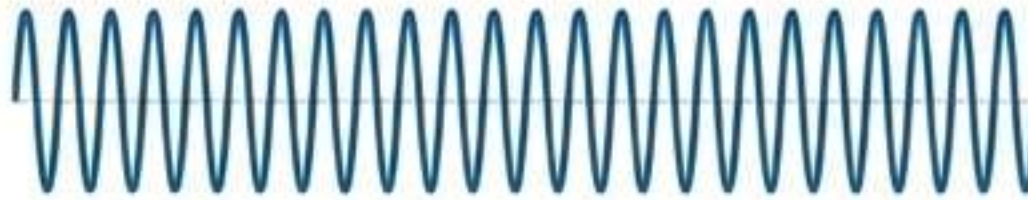


Mouvement : Elliptique

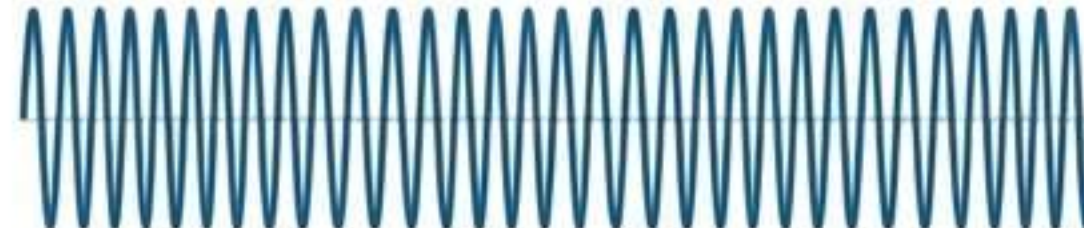
Ultrasonique (Piezo & Magnéto)

Source : Courant électrique

Fréquence : 25,000 – 50,000 Hz



Piezoélectrique (Quartz) /
Magnétostrictif (Lamelles)



Piezoélectrique (Quartz) /
Magnétostrictif (Lamelles)

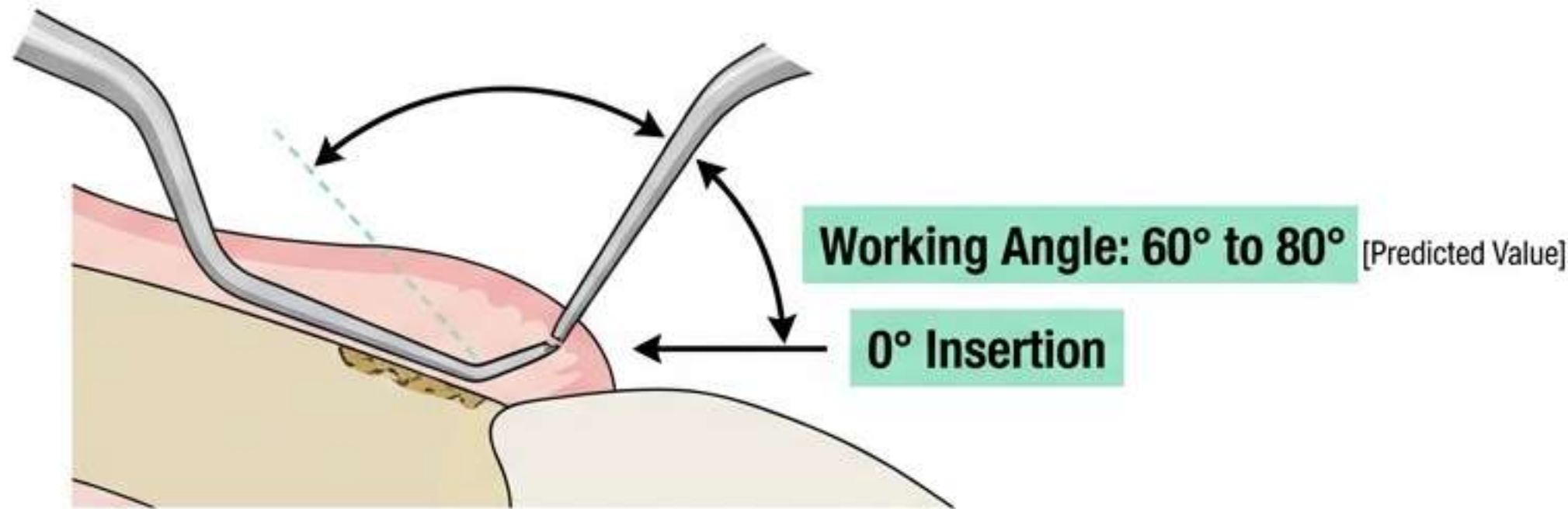
Avantages / Inconvénients

- Vitesse accrue [Ref: Q16]
- Cavitation & Irrigation (Antibactérien)
- Inconvénient : Perte sensation tactile [Ref: Q18]

Contre-Indication :
Maladies infectieuses (HIV, Hépatite) à cause des **aérosols**. [Ref: Q16]

Technique d'Instrumentation & Protocoles

Technique d'Instrumentation



1. **Insertion** : Face lisse contre gencive (0°).
2. **Position de travail** : Ouvrir l'angle.
3. **Angle de Travail** : 60° à 80° [Predicted Value]
4. **Mouvement** : Traction (Apico-coronaire).
5. **Point d'appui** : Stable (Intra-oral / Annulaire) [Ref: Q20].

Protocoles & Modalités

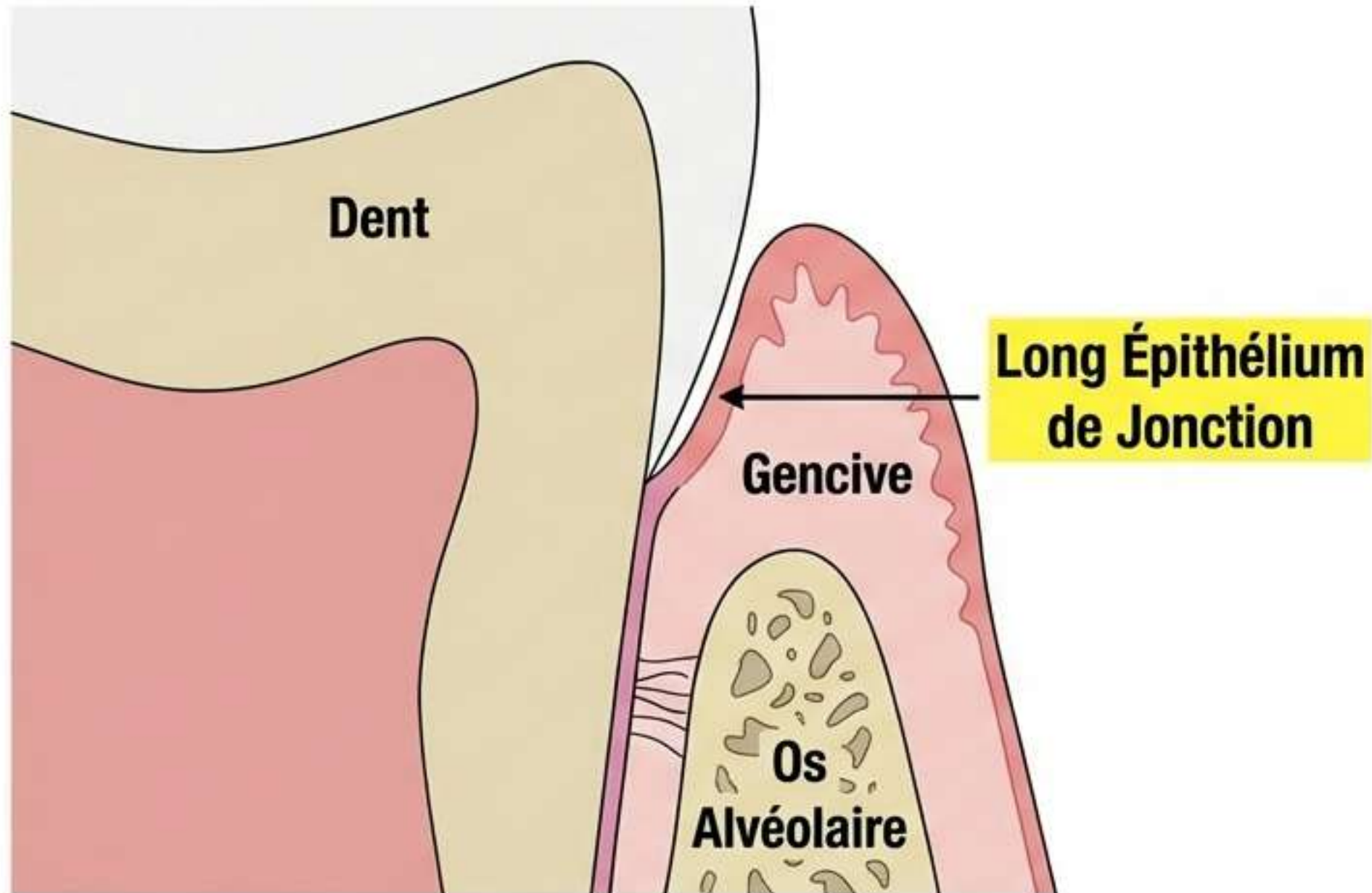
- Par Sextants ou Quadrants.

Full Mouth Debridement :

Traitement complet en < 24h.

Prévient la réinfection des poches
traitées (Cross-contamination).
contamination). [Ref: Q14, Q19]

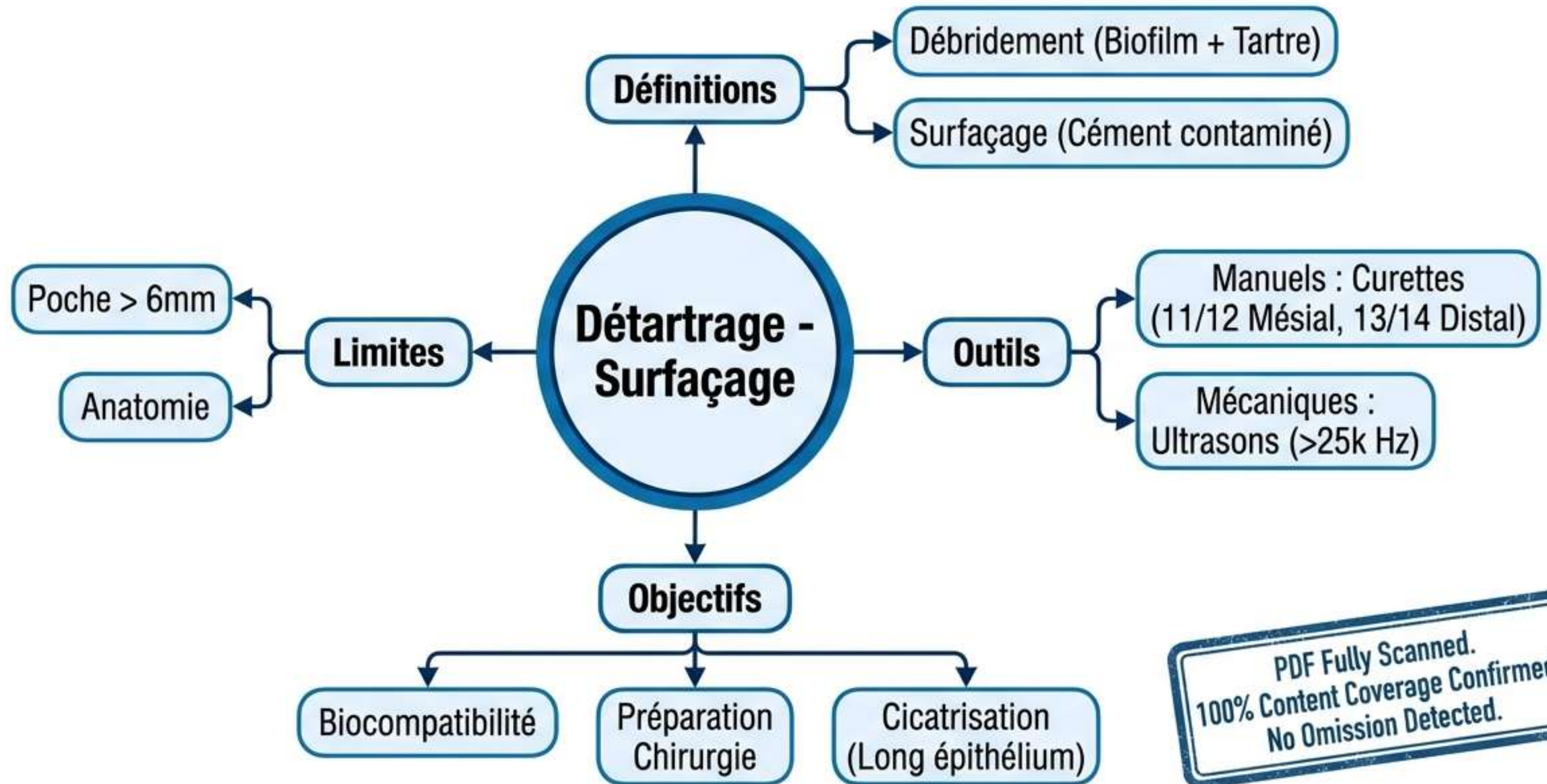
Cicatrisation et Résultats



- Résolution de l'inflammation (Rétraction, arrêt saignement).
- Réduction de la profondeur de poche. [Ref: Q15]
- **Histologie : Long Épithélium de Jonction.** (Pas de nouvelle attache osseuse). [Ref: Q15]
- **Microbiologie :** Retour à une flore 'normale' compatible santé.

Facteurs d'échec : Mauvaise hygiène, Tabac (immunité réduite), Furcations, Maladies systémiques.

Synthèse : Traitement Parodontal Non-Chirurgical



PDF Fully Scanned.
100% Content Coverage Confirmed.
No Omission Detected.